



**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA**

ESCUELA DE ENFERMERIA

PLAN DE TESIS

**IMAGEN SOCIAL DE LA ENFERMERA SEGÚN LA PERCEPCION DE
LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD MATERNO
INFANTIL SURQUILLO, 2024**

PARA OPTAR

EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERIA

PRESENTADO POR:

**IORELLA ISABEL CUZCANO VILLANUEVA
PRICILA YERLISA ROMERO AREVALO**

ASESOR (A)

DRA. LAURA PATRICIA ROA CAMPOS

LIMA, PERÚ

2024

ÍNDICE

	Págs.
Portada	i
Índice	ii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1 Descripción de la situación problemática.....	1
1.3 Objetivos de la investigación.....	5
1.4 Justificación de la investigación	6
1.4.1 Importancia de la investigación.....	6
1.4.2 Viabilidad del estudio	7
1.5 Limitaciones de estudio	8
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	9
2.1 Antecedentes de la investigación.....	9
2.2 Bases teóricas.....	13
2.3 Definición de términos básicos	22
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS (si las hubiera) Y VARIABLES.....	25
3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas (si las hubiera).....	25
3.2 Variables y definición operacional	25
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA	26
4.1 Diseño metodológico.....	26
4.2 Diseño muestral	26
4.3 Técnica de recolección de datos	27
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.....	29
4.5 Aspectos éticos.....	29
CRONOGRAMA	31
PRESUPUESTO	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
ANEXOS	43

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

Enfermería es la ciencia y disciplina que se encarga del cuidado autónomo y colaborativo a los pacientes, de realizar trabajos asistenciales y prestar servicios de promoción, prevención y rehabilitación, en las personas, familias y comunidades.

La imagen que se proyecta de la carrera puede ser vista o percibida de distintas formas, algunas podrían ser negativas, otras positivas, todo esto de acuerdo la percepción de la persona. Es así que muchos de ellos perciben que es una carrera sacrificada y muy humana, aunque también poco independiente y menos valorada que otras carreras¹.

Calvo² menciona que la identidad o esencia de las enfermeras no concuerda con su imagen social, la imagen está plagada de estereotipos y el público sigue percibiendo una imagen dependiente y poco profesional de las enfermeras.

Por otra parte, Franco³ refiere que una pobre identidad profesional ocasiona que los enfermeros no visibilicen sus cuidados y como resultados la imagen social se vea deteriorada. De esta forma los estigmas del pasado continúen en el presente y sigan afectando su imagen no solo en la sociedad, también ante sus propios colegas, compañeros, y entorno cercano. Por ello hay que fortalecer la autoimagen, y aumentar la identidad y liderazgo.

La Organización Mundial de la Salud⁴, declaró que el 2020 era “el Año Internacional de las Enfermeras”, como homenaje a todas las enfermeras quienes brindan sus

servicios de cuidados y que aportan sus conocimientos para la población y el desarrollo a la salud. Todo esto impulsando al empoderamiento y liderazgo de la profesión con la opinión de Nursing Now. Por otro lado, en el estudio realizado en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras, hallaron que el 90% de los profesionales son mujeres, y son pocas las que ocupan puestos directivos en los servicios de salud, estos puestos son ocupados por hombres. Por ello se hace llamamiento al fortalecimiento del liderazgo de las enfermeras a nivel mundial⁵.

Según la Organización Panamericana de Salud⁶ en el año 2020, llama a considerar la importancia de la inversión en la educación, el empleo, liderazgo y la práctica de enfermería. Afirma que las Américas tiene el 30% aproximadamente 8.4 millones del total de enfermeros incluidos profesionales, técnicos y auxiliares. Se estima que hay una escasez mundial de 5.9 millones, y que el 89% (5.3 millones) de este déficit se concentra en países de ingresos medio bajos y bajos. Esta problemática no solo se ve en Latinoamérica, también es de origen mundial, si no se prioriza pronto generara problemas a nivel del sistema de salud.

El Colegio de Enfermeros del Perú⁷ realizó un diagnóstico de la situación nacional del profesional de enfermería, como resultado existe un gran déficit de enfermeras, hay 15 por cada 10.000 personas, se debería contar con 88 por cada 10.000 habitantes; para lograr el objetivo se deberá contar con 250.000 enfermeras. En la actualidad esta cifra es lejana, si bien se contrataron varios miles, muchas dejaron de laborar o fallecieron durante la pandemia. Actualmente de los 96 000 enfermeros colegiados, solo 57 000 ejercen la carrera.

Otra situación compleja por la que atravesó nuestro país fue la pandemia, que golpeó significativamente a todos los profesionales de salud, se cuentan miles de enfermeras que fueron contagiadas, otras fallecieron, estando en primera línea. Peso a ello muchas han estado con contratos temporales, con gran condición de vulnerabilidad y poniéndose en riesgo, hasta la actualidad no logran conseguir pasar de CAS a ser nombradas⁸.

Las enfermeras hoy en día luchan por su reconocimiento, pero la feminización de la profesión ha tenido efectos laborales, sociales, de política. Sus funciones son percibidas como poco complejas y cumplidas por los médicos, siendo ellos en su mayoría del sexo masculino, llevándose muchas veces el crédito de toda la labor de salud brindada y no siendo cuestionadas las grandes diferencias salariales. De gran manera los estereotipos hacen que la enfermera este lejos de una labor calificada y sofisticada. Sin embargo, se ha ganado más reconocimiento social en las últimas décadas, pero todavía queda un largo camino por recorrer⁹.

En cuanto a la forma de vestir, en Perú, de acuerdo al Código de Ética en el Artículo 70, señala que el profesional de enfermería debe vestir el uniforme de acuerdo a las normas institucionales, es decir proteger su imagen y presentación. Todo esto debido a que al lucir el uniforme reglamentado y de manera correcta, este inspira confianza, respeto y proyecta su imagen de profesionalismo, además de proporcionar seguridad y protección al mismo profesional. Aspecto no menos importante a tener en cuenta es que la gran mayoría de la población no tiene claro aún cual es el uso correcto del uniforme reglamentado, es por ello que se debe considerar seguir trabajando en ese aspecto¹⁰.

Estudios como el de Ancco¹¹ nos muestra que la imagen social de la enfermera es abordada desde muchas perspectivas, en las cuales intervienen factores económicos, laborales, profesionales sociodemográficos y geográficos.

En otro estudio nacional Lobato¹² evidencio que la imagen del profesional esta distorsionada, no se asemeja a lo que se promueve en las universidades, ni a las funciones que desarrollan.

La imagen social de la enfermería no se limita únicamente a la persistencia de algunos estereotipos, ni a las percepciones negativas por parte de algunas personas. Esta imagen se está mejorando y construyendo a partir de las diversas funciones desempeñadas, como el de la investigación, administración, docencia, lo asistencial, la calidad de sus atenciones, su forma de actuar y su visión de futuro. Con el continuo crecimiento científico, el aumento de liderazgo y la búsqueda de la igualdad salarial, las enfermeras aspiran no solo a alcanzar un salario justo, sino también a ocupar roles destacados en el ámbito profesional y político.

Durante la experiencia del internado comunitario en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más los puntos de vista dados por las personas que acudían para su atención, algunos comentaban que no distinguían a las profesionales de enfermería con las técnicas de enfermería, no sabían cuál era la diferencia en cuanto a las funciones que realizaban, de igual modo en cuanto a la vestimenta que usaban; algunas veces había demora por la cantidad de pacientes y tardaban en ser atendidos por la falta de personal. Al igual indicaron

que recibieron un trato un poco frío y distante, que lo asociaban con la falta de tiempo para la atención y algunas veces por la falta del personal.

Todas estas acciones generadas por parte de los profesionales de enfermería, crean en los usuarios, ideas, emociones y percepciones de la imagen que proyectamos. Es por este motivo que se decide realizar la presente investigación el centro salud Surquillo, para poder brindar la información de los resultados de la investigación a las entidades correspondientes.

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la imagen social de la enfermera según la percepción de los pacientes que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo general:

- Determinar la imagen social de la enfermera según la percepción de los pacientes que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024

Objetivos específicos:

- Identificar la imagen social de la enfermera en la dimensión información según la percepción de los pacientes que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024.

- Identificar la imagen social de la enfermera en la dimensión actitud según la percepción de los pacientes que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024.
- Identificar la imagen social de la enfermera en la dimensión estatus social según la percepción de los pacientes que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La imagen de la enfermera la construye la sociedad en su mente a partir de lo que estos transmiten voluntariamente o no, es decir la imagen resulta de la suma de experiencias que se forman de la interacción con la enfermera. Entonces, la imagen que se tiene de enfermería como profesión es resultado de las percepciones de los usuarios y de lo que proyecta la enfermera en sus labores.

Realizar esta investigación es de suma importancia porque mediante esta información, será posible revelar la realidad y la magnitud del problema en relación con la imagen social de la enfermera, a través de los resultados obtenidos.

La presente investigación tendrá un impacto social, porque permitirá conocer actualmente si la imagen y la percepción que tiene la población de la enfermera es favorable o desfavorable, y a través de estos resultados, las autoridades correspondientes podrán implementar las medidas adecuadas y correctivas, para que la población pueda identificar las diversas funciones y actividades del

desarrollo de las competencias y habilidades del profesional de enfermería, y así sus demandas de atención sean satisfechas.

A nivel institucional, de acuerdo a los resultados obtenidos, se podrá implementar estrategias de mejora que contribuyan a favorecer la imagen y el prestigio de la enfermera ante la sociedad, contribuyendo así también a elevar el estatus de la institución y del profesional, y favorecer la percepción de la comunidad sobre la atención proporcionada por las profesionales de enfermería.

Desde la perspectiva profesional, esta investigación permitirá a las enfermeras, poseer una comprensión más clara de las ideas y percepciones que las personas tienen sobre ellas. Con estos resultados se pretende sensibilizar al profesional de enfermería y servirá como estímulo para su crecimiento profesional, incentivándolas a mejorar, elevar su imagen, fortalecer su liderazgo y buscar constantemente nuevas formas de cambios y mejoras.

Así mismo, la información recopilada quedara como precedente para que posteriormente se puedan continuar con otras investigaciones.

1.4.2 Viabilidad del estudio

El trabajo de investigación es factible debido a que se va solicitar el permiso a las autoridades responsables del Centro de Salud Surquillo, para poder contar con el acceso a los pacientes que acuden, para aplicar el instrumento de recolección de datos.

A nivel personal se cuenta con el tiempo que requiera la investigación para su elaboración y con las herramientas intelectuales necesarias, así como el acceso a bibliotecas virtuales.

Así mismo se cuenta con los recursos financieros para cubrir los diversos gastos como copias, impresiones, viáticos entre otros, para el traslado al campo de investigación y de esta manera realizar el proyecto, respecto a los materiales se tiene una computadora para realizar el escrito, libros y artículos científicos para elaborar el análisis teórico.

1.5 Limitaciones de estudio

Los resultados de la investigación solo serán utilizados para la institución donde se realizará el estudio.

La poca colaboración de la población.

Otra limitación es el tema de los horarios y coordinaciones y todo trámite administrativo que tiene un tiempo de demora.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Bustamante¹³, et al, en el 2022, en México, realizó un estudio titulado: “Percepción Social de universitarios externos al área de la salud respecto Enfermería”. La metodología fue de estudio cualitativo, descriptivo. Se aplicó como instrumento una entrevista, a 30 participantes. Los resultados fueron: Se demostró que existe una visión más amplia de enfermería, sus funciones y su importancia en cuanto al nivel académico que tienen los participantes; en cuanto al conocimiento resalta la confianza que tienen indistintamente del género al que pertenezcan el profesional de enfermería.

Herrera¹⁴, en el 2022, en España, desarrollo un artículo sobre “Imagen social de Enfermería: visibilidad de los cuidados, en la revista: Conocimiento Enfermero. Su metodología fueron cinco bases de datos, seleccionados y analizados 14 artículos. Los resultados fueron: consideran que tiene un prestigio menor que otras profesiones, desconoce el campo competencial y la esencia profesional; en autonomía: conocen algunas funciones, pero persiste la visión como ayudante de la medicina; en reconocimiento de funciones: creen que están mejor preparadas que en años anteriores, y reconocen sus funciones habituales; en atributos personales: no lo vincula exclusivamente al sexo femenino; en competencias y confianza: confía cada día más.

Verena¹⁵, en 2021, Argentina, desarrollo un artículo sobre: “La imagen social sobre los Profesionales de Enfermería que tiene una Comunidad de Misiones, Argentina”, en la revista: Unidad Sanitaria XXI. Su metodología fue de abordaje cuantitativo, descriptivo, muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó como instrumento una entrevista, a 30 unidades de análisis. Los resultados en la dimensión formación: el 50% cree que tiene estudios universitarios, 32% terciario, 7%especialidad, 7% auxiliar, 4% no sabe. Los resultados muestran que la comunidad hasta ahora mantiene en sus concepciones del profesional de enfermería una alta influencia de sus orígenes en cada una de sus etapas de los cuidados, y que la presencia y las actividades de los profesionales de enfermería en el equipo de salud es fundamental.

López¹⁶, 2021, en Costa Rica, hizo un artículo sobre: “Apariencia y masculinidad en enfermería: percepción de la vestimenta de enfermeros costarricenses”, en la revista: Enfermería Universitaria. La metodología fue cualitativa, de corte fenomenológico. Aplicó como instrumento una entrevista, a 8 enfermeros. Obtuvo como resultado, que: La imagen social prevaleciente corresponde a la enfermera vestida de blanco; sin embargo, existen prácticas y discursos que pretenden reformular esa imagen para legitimar la presencia de los varones en la profesión, situarlos en las posiciones superiores y legitimarlos en esos sitios.

Marzón¹⁷, el 2020, en Ecuador, realizo un estudio titulado: “Reconocimiento social de enfermería: opinión de la profesión en la actualidad”. Su metodología fue de estudio documental, descriptivo, comparativo y analítico. Aplico como instrumento

un cuestionario, a 49 pacientes. Los resultados muestran que: en la actualidad se han dado cambios socioculturales y académicos, sin embargo, aún lo relacionan con un grado de formación de estudios deficiente y estereotipos sexistas, que son transmitidos en medios de comunicación, generando esta percepción de la profesión.

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL

Ancco¹¹, en el 2022, Perú, hizo un estudio titulado: “Imagen social del profesional enfermero (a) según percepción de usuarios que acuden al Centro de Salud – San Jerónimo, Cusco”. Su metodología de estudio cuantitativo, descriptivo, corte transversal. Se aplicó un cuestionario, a 215 usuarios. Teniendo como resultado, del 100%, el 97.9% poseen una buena o excelente percepción, y solo el 2.3% tiene una percepción regular.

Cajachagua¹⁸, et al; en el 2022, en Perú, realizaron un artículo titulado: “Cuidado invisible e Imagen social de la enfermera comunitaria”. Su metodología fue de estudio correlacional, transversal. Se aplicaron dos test a 514 personas. Los resultados muestran: el cuidado invisible es alto en un 57.8%, regular en un 76.9%; imagen social: alta 57.8%, baja 76.9%.

Phala¹⁹, et al, 2021, en Perú, hicieron un estudio titulado: “Imagen social del enfermero rural según la percepción de los usuarios atendidos en establecimientos rurales de Puno, Lima y Loreto”. Su estudio es cuantitativo, transversal de tipo comparativo. Aplicaron una encuesta a 537 usuarios. Sus resultados demostraron

que: existen diferencias estadísticas considerables entre la imagen social del profesional de enfermería y la percepción de los usuarios por departamentos ($p<.001$), se evidenció la diferencia según el lugar, en la dimensión Información ($p<.001$), en la dimensión campo de presentación ($p=.001$), en la dimensión actitud ($p=.037$) y en la dimensión religión ($p<.001$).

Peñañiel²⁰, en el 2021, en Perú, desarrolló un estudio titulado: “Percepción Social de la Profesión de Enfermería que tienen los Pobladores Adultos del Centro Poblado “Zona Nueva” Parcona, Ica”. Su metodología fue cuantitativa, transversal, correlacional. Aplico como instrumento un cuestionario, a 173 pobladores. Como resultado: En la dimensión información el 52.6% es regular, 24.3% mala y 23.1% buena, siendo esta ultima la más baja; en campo de representación: 61.9% tiene una regular, 26% mala y 12.1% buena; en actitud: 60.1% es regular, 24.3% buena, 15.6% mala. En general la percepción es regular en un 53.8%, en un 23.1% es buena, y mala 23.1%.

Lobato¹², et al, 2020, en Perú, realizo un artículo sobre: “Percepción de la imagen social del profesional de enfermería, Chachapoyas, región Amazonas”. Su metodología fue descriptiva, cuantitativa, prospectiva, transversal y univariado. Se aplicó como instrumento un cuestionario, a 49 pacientes. Los resultados fueron: el mayor porcentaje 73.5% indican que tienen una percepción desfavorable en la dimensión informática, solo el 26.5% favorable; en la dimensión de actitud, el 75.5% percepción favorable, 24.5 desfavorable. Del 100%, el 54% es favorable y

el 46% es la percepción desfavorable. Se observa que no hay diferencia significativa con lo desfavorable.

2.2 Bases teóricas

2.2.3. Imagen social:

Se refiere a la percepción que tiene el público sobre una persona, empresa, marca o entidad en el ámbito social. Como resultado de esta interacción, se forma una impresión general a través de la comunicación, visualización, experiencia, entre otros. La imagen social no solo se basa en la realidad objetiva, sino también en las percepciones y las interpretaciones subjetivas de las acciones, mensajes y comportamientos²¹.

La construcción de una imagen social positiva es crucial para el éxito de individuos, empresas y organizaciones. Factores como la calidad del producto o servicio, la ética empresarial, la responsabilidad social, la comunicación efectiva y la reputación desempeñan un papel importante en la formación de la imagen social²¹.

Por imagen social entendemos una creación icónica y sencilla basada en estereotipos, que representa a través de atributos el discurso de un entorno sociocultural concreto respecto de una realidad social. Es un concepto consensuado por los miembros de una sociedad sobre las representaciones sociales construidas ante una realidad que pretende resumir visualmente determinado discurso social a través de las características que mejor se ajustan al contenido ideológico o moral.

La imagen social basada en relaciones sociales establecidas a través de medios y recursos comunicativos se refiere a la percepción que una persona tiene en la sociedad, formada principalmente por las interacciones y comunicaciones que realiza a través de diversos canales. De esta manera, una actitud transparente y auténtica puede generar confianza, además de mantener coherencia entre las palabras y las acciones, lo cual es esencial para mantener una imagen positiva. Además, mostrar empatía hacia los problemas sociales, trabajo en equipo, la forma en la que se abordan los desafíos y crisis, pueden influir positivamente en la imagen social²².

2.2.1. Imagen social de la enfermera

La imagen social de las enfermeras es una representación colectiva y percepción que la sociedad tiene acerca de las enfermeras como profesionales de la salud. Esta imagen es influenciada por diversos factores, incluyendo la cultura, los medios de comunicación, las experiencias personales y la educación.

La imagen social comúnmente resalta a las enfermeras como cuidadoras compasivas y comprometidas. La idea de que están allí para brindar apoyo emocional y físico a los pacientes contribuye positivamente a su percepción. Las enfermeras suelen ser vistas como profesionales de confianza y cercanos a los pacientes. La confianza es crucial en la relación de atención médica, y las enfermeras son a menudo percibidas como figuras confiables²².

Sin embargo, un número desequilibrado de enfermeras y pacientes, la alta presión laboral, la falta de identidad social ocupacional y otras razones han provocado agotamiento laboral, baja satisfacción laboral e incluso la renuncia de muchas

enfermeras. Las investigaciones también han demostrado que la falta de profesionalismo de enfermería afecta negativamente a la atención y los resultados de los pacientes, señalando que niveles más bajos de profesionalismo pueden causar resultados negativos, como rotación, desgaste y menor productividad²³.

Por otro lado, los medios de comunicación reflejan frecuentemente estereotipos que resultan degradantes y ejercen una influencia negativa en la imagen de la profesión de Enfermería. De esta manera, se evidencia cómo en películas, series de televisión, comerciales e informativos, se proyecta una imagen distorsionada de las competencias de Enfermería, que nada tiene que ver con el verdadero compromiso de este colectivo hacia la salud de la población.

En consecuencia, la imagen social impacta negativamente en la construcción de la identidad profesional, porque la población condiciona los pensamientos, creencias y comportamientos del personal; y, a su vez, lo que los profesionales de enfermería transmitan a través de sus acciones va a determinar la imagen pública existente de la profesión²⁴.

La imagen pública de la enfermería está dada por su aspecto externo, por el esquema mental del concepto de la profesión (que está determinado por palabras o imágenes), y por su semejanza en relación con otras profesiones, donde el conjunto de características que se repiten mediante las diversas representaciones y experiencias de los individuos es lo que constituye la imagen social de la profesión²⁵.

2.2.2. Dimensiones de la imagen social de la enfermera

a. Información

Generalmente, el término se define como datos procesados que representan mensajes sobre una entidad o evento específico y permiten a las personas obtener el conocimiento que necesitan para tomar decisiones en su vida diaria. Es una parte fundamental de la vida diaria en la comunidad y también es necesaria para tener una comunicación efectiva entre los individuos.

Es así que la información pública sobre la profesión de enfermería juega un papel crucial en la formación de la imagen social. Esto incluye la comprensión de las responsabilidades, habilidades y contribuciones de los enfermeros en la atención de la salud²⁶.

Otra información que deben tener las personas en relación a enfermería es la imagen física, que es un componente evidente y tangible que los pacientes perciben. Incluye aspectos como la higiene personal, la vestimenta profesional, la postura y el lenguaje corporal. La presentación física de la enfermera puede influir en la confianza y la comodidad que los pacientes experimentan durante la atención. Un aspecto cuidado y profesional puede contribuir a una percepción positiva²⁷.

Y toda esta percepción de que la enfermera posee conocimiento científico es esencial para la confianza del paciente. Esto implica no solo tener una base teórica sólida, sino también aplicar ese conocimiento de manera práctica y efectiva en la atención. De esta manera, la comunicación clara y la capacidad para responder preguntas relacionadas con el tratamiento y la atención contribuyen a esta percepción²⁸.

Por otro lado, la participación activa de la enfermera en actividades preventivas y promocionales de la salud puede influir positivamente en la percepción de los

pacientes. Además, la educación sobre hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la promoción del bienestar demuestran un compromiso con la salud a largo plazo y refuerzan la importancia del papel de la enfermera en la atención integral²⁹.

Así pues, la responsabilidad y el ejercicio de un criterio ético son fundamentales para la percepción positiva de la enfermera. Los pacientes esperan que la enfermera actúe con integridad, siga protocolos y tome decisiones basadas en la evidencia científica. Por lo tanto, la transparencia en la toma de decisiones y la comunicación abierta refuerzan la confianza del paciente³⁰.

De otro modo la autonomía de la enfermera en la toma de decisiones puede influir significativamente en cómo los pacientes perciben su capacidad para brindar atención individualizada y centrada en el paciente. La capacidad de tomar decisiones informadas, adaptarse a situaciones cambiantes y colaborar eficazmente con otros profesionales de la salud contribuye a una imagen de enfermera empoderada y capaz³¹.

b. Actitud

Otro aspecto importante de las dimensiones es la actitud, que es definida como la manera en cómo se comportan y actúan las personas.

Con referencia a las habilidades interpersonales de la enfermera son esenciales para establecer relaciones efectivas con los pacientes. Esto implica la capacidad de empatizar, demostrar compasión y mostrar sensibilidad hacia las necesidades emocionales de los pacientes. Habilidades como la escucha activa, el respeto y la empatía contribuyen a un ambiente de atención centrado en el paciente³².

Además, la comunicación efectiva es un pilar crucial en la atención de enfermería. Esto incluye la capacidad de transmitir información de manera clara y comprensible, así como de escuchar las preocupaciones y preguntas de los pacientes. Así mismo, la comunicación abierta y transparente fortalece la confianza y permite una comprensión mutua entre la enfermera y el paciente³³.

En cuanto a los valores practicados por la enfermera influyen directamente en la percepción del paciente. Estos valores incluyen la ética, la integridad, la honestidad y el respeto. La práctica coherente de estos valores contribuye a la construcción de una relación de confianza y respeto mutuo entre la enfermera y el paciente. Las actitudes emocionales que puede tener el personal de enfermería hacia los pacientes como la empatía y el respeto, son aspectos importantes de la imagen social. Las interacciones positivas y la percepción de las enfermeras como cuidadoras compasivas pueden influir en las actitudes del público³⁴.

c. Estatus social

El estatus social se asocia con la posición de una persona en la sociedad, por su prestigio o en relación a su honor.

La enfermera es un profesional de vital importancia cuya labor es ampliamente reconocida y apreciada por la sociedad. Su papel va más allá de la prestación de cuidados de salud básicos, abarcando aspectos fundamentales que contribuyen al bienestar general de la comunidad. Además, la enfermera es una figura esencial en el sistema de atención médica, reconocida por la sociedad por su dedicación, compasión y contribuciones invaluable para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. Su labor incansable y su compromiso con la atención centrada en el

paciente la convierten en un pilar fundamental en la prestación de servicios de salud de calidad³⁵.

El valor social está intrínsecamente relacionado con la apreciación y la comprensión de la labor fundamental que desempeñan las enfermeras en la atención a los pacientes y en la promoción de la salud, la cual se basa en su capacidad para proporcionar cuidado y apoyo emocional a los pacientes. Además, la adaptabilidad y resiliencia de las enfermeras frente a desafíos y situaciones complejas resaltan su capacidad para proporcionar cuidados continuos y de calidad, lo cual contribuye al valor social de su profesión³⁶.

2.2.3. Percepción

La percepción es el proceso mediante el cual las personas interpretan y comprenden la información sensorial que reciben del entorno. Involucra la organización, interpretación y asignación de significado a estímulos sensoriales como sonidos, imágenes, olores y sensaciones táctiles. La percepción también un proceso complejo que varía entre individuos y está influenciado por una serie de factores. Comprender cómo percibimos el mundo nos permite ser más conscientes de nuestros propios sesgos mejorando la comunicación y comprensión con los demás³⁷.

En relación con la percepción del usuario, se refiere a la información recopilada sobre sus experiencias pasadas, relacionadas con el cuidado, que se obtiene a través de las impresiones transmitidas por los sentidos del paciente y las impresiones directamente relacionadas con la atención brindada por la enfermera. Dependen también las características del usuario, como sus expectativas, los

factores personales, formas de pensar y cultura. La percepción que tiene la persona hacia el profesional de enfermería es entonces basada en factores como la atención personalizada y diferenciada, el cuidado humanístico que da de manera continua, la información eficiente y la actitud brindada, que se deberían de cumplir y mantener de acuerdo a los estándares profesionales. Todo esto con el propósito de obtener una percepción positiva de parte del usuario, en favor de su bienestar y mejora³⁸.

2.2.4. Enfermería

La enfermería es una disciplina de la salud que se centra en la atención integral de las personas, familias y comunidades para mantener, promover y restablecer la salud³⁹. Los profesionales de enfermería desempeñan un papel crucial en la prestación de cuidados, trabajando en colaboración con otros profesionales de la salud para garantizar la calidad y la continuidad de la atención⁴⁰.

Es una profesión integral que abarca una amplia gama de responsabilidades y actividades para proporcionar cuidados holísticos a los individuos y comunidades. El rol del enfermero como profesional de la salud es intervenir en la prestación de los servicios integrales de salud, de manera científica, humanística, sistemática, en lo tecnológico, los procesos de promoción, prevención recuperación y rehabilitación de la salud, mediante los cuidados a la comunidad, la familia y la persona⁴¹.

Teoría de Enfermería

La presente investigación será sustentada con la teoría de Florence Nightingale quien nos habló de cómo aplicar conceptos novedosos en la práctica de enfermería, y hacer que se reduzcan las tasas de mortalidad. Sus contribuciones, como establecer la necesidad de saneamiento, reconocer los requisitos dietéticos, brindar atención al paciente las 24 horas, instituir el triaje, recopilar evidencia estadística, fomentar la educación y promover la defensa, forman la base de la enfermería.

La perspectiva única de Nightingale sobre la práctica de la enfermería se centró en la relación de los pacientes con su entorno. Estableció principios que fueron fundamentales para la enfermería y siguen siendo relevantes para la práctica de la enfermería en la actualidad. Por ejemplo, su descripción de la importancia de observar al paciente y registrar la información con precisión y sus principios de limpieza todavía dan forma a la práctica de enfermería hospitalaria en la actualidad. Nightingale centró la profesión en lo que se conoce como el metaparadigma de la enfermería: persona (paciente), salud (a diferencia de la enfermedad), medio ambiente (cómo el entorno afecta la salud y la recuperación de la enfermedad) y enfermería (a diferencia de la medicina).

Nightingale creía que la salud de los pacientes estaba relacionada con su entorno. Reconoció la importancia del aire y el agua limpios y de una ventilación y luz solar adecuadas y alentó a que se dispusieran las camas de los pacientes de modo que estuvieran expuestas a la luz solar directa. En su escrito, describió tanto la necesidad de una dieta equilibrada como la responsabilidad de la enfermera de observar y registrar lo que se come. La limpieza del paciente, la ropa de cama, el

problema del ruido en las habitaciones y pasillos de los hospitales, lo que presagiaba la atención prestada al exceso de ruido en los entornos hospitalarios en los últimos años. El descanso es importante en el restablecimiento de la salud; ya que la interrupción repentina del sueño era un problema grave. La relación entre la salud y el medio ambiente parece obvia hoy en día, pero para la enfermería de la segunda mitad del siglo XIX, el trabajo de Nightingale fue radicalmente diferente⁴².

2.3. Definición de términos básicos

Enfermera: El enfermero(a) es el profesional que presta un servicio a la sociedad, cuya labor primordial es cuidar y proveer de bienestar al paciente¹⁴.

Percepción: Es una función cognitiva fundamental que influye en cómo percibimos y entendemos nuestro entorno²⁰.

Usuario: Persona que acude a un establecimiento de salud para recibir una atención²⁸.

Imagen social: Valor social asignado por los usuarios en función de determinados comportamientos de la enfermera⁴³.

Responsabilidad: Se define como el deber de asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Implica la capacidad de cumplir con los

compromisos y de tomar medidas conscientes para llevar a cabo tareas o responder por las consecuencias de nuestras elecciones⁴³.

Valores: Principios fundamentales que guían el comportamiento y las decisiones de una persona. Estos son conceptos fundamentales que una sociedad o individuo considera importantes y que influyen en la forma en que se percibe el mundo y se toman decisiones éticas⁴⁴.

Actitud: Disposición emocional o conducta que una persona adopta hacia algo, alguien o alguna situación determinada⁴⁴.

Autonomía: Capacidad de una persona para tomar decisiones y actuar de manera independiente, basándose en su propio criterio y libre albedrío⁴⁵.

Comunicación: Proceso de intercambio de información, ideas, pensamientos y emociones entre dos o más personas⁴⁶.

Emocional: Estado afectivo que se experimenta como respuesta a estímulos internos o externos. Estas respuestas emocionales pueden involucrar cambios psicológicos, fisiológicos y de comportamiento⁴⁷.

Interacción: Interacciones conductuales entre personas al relacionarse, teniendo en cuenta el contexto de ese momento⁴⁸.

Comunicación: Es un proceso interactivo mediante el cual la mayoría de los seres humanos envían mensajes detectando códigos compartidos y comunes⁴⁸.

Empatía: Se dice que es el arte para entrar en el interior de la otra persona, una respuesta emocional, de sentimientos de cuidado, interés y compasión dirigidos hacia los demás, surgen del reconocimiento de su sufrimiento⁴⁹.

Conocimiento: Es el acto de informar la realidad responde básicamente a las acciones humanas⁵⁰.

Atención: El acto o situación en el que una persona presta atención y escucha u observa lo que le dicen o lo que está haciendo⁵¹.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas

3.2 Variables y definición operacional

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	
Imagen social de la enfermera	Apariencia que crean las personas acerca de la enfermera para reconocerla agrupando en esa imagen las cualidades que esta proyecta.	Información	Imagen física Posee conocimiento científico Desarrolla actividades Preventivo promocionales Actúa con responsabilidad y criterio Autonomía Toma de decisiones	Favorable:34-48 puntos Desfavorable: Menor a 34	Puntuación general Imagen social: -Favorable: 56-80 -Desfavorable: Menor a 56
		Actitud	Habilidades interpersonales Comunicación Valores Practicados	Favorable: 17-24 puntos Desfavorable: Menor a 17	
		Estatus social	Valor social	Favorable: 6 a 8 puntos Desfavorable: Menor a 6	

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

La presente investigación es de enfoque cuantitativo; respecto al diseño, según Hernández⁵² planteó lo siguiente:

No experimental: Porque no existirá manipulación de alguna variable.

Descriptivo: Describir las características o propiedades de un fenómeno o población particular, sin que exista intervención de las investigadoras.

Transversal: Porque la ejecución se dará a través de la entrega de cuestionarios en un solo momento.

Prospectivo: Debido a que la recolección de los datos se dará en un tiempo actual según sucedan los hechos.

4.2 Diseño muestral

Población:

La población total está conformada por 245 pacientes, que son citados mensualmente en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo. Estos datos han sido estadísticamente por la institución.

Muestra: El tamaño muestral se determinó a través del programa Open Epi con un 95% de confianza, una probabilidad esperada del 50% y una precisión del 5%, para una población de 245 pacientes. De esta manera, se obtuvo un tamaño muestral de 150 pacientes utilizando un muestreo probabilístico aleatorio simple, a través de la siguiente fórmula:

$$n = [EDFF \cdot Np(1-p)] / [(d^2/Z^2(1-\alpha/2)^2(N-1) + p(1-p))]$$

Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)(N): 245
 frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p): 50% +/- 5
 Límites de confianza como % de 100(absolute +/- %)(d): 5%
 Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza

IntervaloConfianza (%)	Tamaño de la muestra
95%	150
80%	99
90%	129
97%	162
99%	180
99.9%	200
99.99%	211

Ecuación

Tamaño de la muestra $n = [EDFF \cdot Np(1-p)] / [(d^2/Z^2_{1-\alpha/2} \cdot (N-1) + p \cdot (1-p))]$

Resultados de OpenEpi, versión 3, la calculadora de código abiertoSSPropor

Fuente: Open Epi.

Criterios de selección

Criterio de inclusión:

- Pacientes de 18 a 60 años de edad que acudan al centro de salud "Surquillo".
- Pacientes de ambos sexos.
- Pacientes que hablen castellano.
- Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- Pacientes con limitaciones para comunicarse.
- Pacientes con problemas de salud mental.
- Pacientes que no estén afiliados al centro de salud Surquillo.

4.3 Técnica de recolección de datos

Para la recolección de datos se utilizará como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario (**Anexo A**) tomado del estudio de Ramírez⁵⁶; titulado

“Imagen social de la enfermera según la percepción de los usuarios de un centro de salud de lima metropolitana, 2019”. Cabe mencionar que la validez del instrumento se realizó mediante juicio de expertos en el área, contando con seis jueces expertos, para que finalmente se realice una prueba binomial de concordancia, obteniendo un $p=0.01$, siendo de 0.05 con lo que se puede decir que es significativo.

El instrumento consta de los siguientes componentes como datos generales y las instrucciones. Además, el contenido cuenta con 20 ítems de tipo Likert, las dimensiones se dividen en 3 aspectos; 12 enunciados para la dimensión información, 6 enunciados para la dimensión actitud y 2 enunciados para la dimensión estatus profesional.

Se consideró puntuaciones a la escala de medida ni de acuerdo ni en desacuerdo (0), totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), de acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4), para lo cual se calculará el puntaje máximo de 80 puntos, se estableció un rango de valor final para la variable y sus dimensiones, las cuales se definieron como favorable y desfavorable.

Imagen social: - Favorable: 56-80; Desfavorable: Menor a 56

Información (D1): Favorable:34-48 puntos, Desfavorable: Menor a 34

Actitud (D2): Favorable: 17 – 24 puntos, Desfavorable: Menos de 17 puntos

Estatus social (D3): Favorable: 6 – 8 puntos; Desfavorable: Menos de 6 puntos

Como procedimiento para la recolección de datos, en primer lugar, se presentará la solicitud para obtener la carta de presentación. Posteriormente, se mandará una solicitud al director del centro de salud con la finalidad que otorgue los permisos necesarios y poder llevar a cabo la investigación.

Se captarán a los pacientes que estén a la espera de ser atendidos por el servicio de enfermería, en donde se les explicará y dará detalles sobre la investigación. Una vez realizado este proceso, se les brindará el consentimiento informado **(Anexo B)**, donde pasarán a firmarlo para dar fe que serán participantes voluntarios.

Se le brindará el cuestionario junto a un lapicero, donde el tiempo máximo de llenado será 20 min. Una vez terminado, se procederá a guardar los cuestionarios, reservando la identidad de cada individuo.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Se ingresarán los datos a través de una hoja de cálculo en Excel, en donde se ordenarán y tabularán de manera ordenada. El procesamiento de datos se desarrollará utilizando el programa estadístico SPSS versión 26; donde se diseñará las tablas de frecuencia y porcentajes, dando lugar a un análisis descriptivo. Además, se realizarán los gráficos de barras, en donde existirá una representación gráfica de los resultados.

4.5 Aspectos éticos

En el presente estudio se aplicó los principios bioéticos estipulados en la Declaración de Helsinki⁵³, los cuales son:

Autonomía: los pacientes decidirán de manera voluntaria participar de la investigación firmando el consentimiento informado, siendo su decisión respetada. Por otro lado, el participante podrá retirarse de la investigación si lo cree conveniente.

Beneficencia: ya que siempre se buscará el bienestar del paciente a través de los procedimientos, los cuales se consideran seguros.

No maleficencia: el instrumento empleado es un cuestionario auto administrado que no generará riesgo a la salud del participante.

Justicia: ya que todos los participantes serán tratados de la misma manera con el debido respeto. Además, se trabajará con total imparcialidad respecto a la población evaluada.

Cabe mencionar que el proyecto de investigación pasará por una revisión por parte del Comité de Ética de la Universidad San Martín de Porres, dando conformidad al contenido.

CRONOGRAMA

N°	Actividades	Meses					
		Noviembre 2023	Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024
1	Identificación y formulación del problema	x					
2	Revisión de las fuentes de información		x				
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables			x			
4	Determinación del diseño de investigación			x			
5	Determinación del marco muestral			x			
6	Selección de los estadígrafos a utilizar				x		
7	Recolección de datos				x	x	
8	Organización y procesamiento de los datos					x	
9	Análisis e interpretación de los resultados					x	
10	Redacción del informe						x
11	Presentación del informe						x

PRESUPUESTO

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Investigador	---	-----	-----
	Personal para la tabulación	---	----	90.00
	Profesional estadístico	---	--	500.00
	Traducción del documento en ingles	20 hojas	10	300.00
	Sub total			890.00
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tónér de impresión)			180.00
	Materiales de escritorio			20.00
	Sub total			200.00
Servicios	Internet			100.00
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos			120.00
	Movilidad			100.00
	Sub total			320.00
Total general				1410.00

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gavilanes V. Enfermería de la ocupación a la profesión, de la profesión a la ciencia. Pol Con [Internet]. 2022. [citado 24 de mayo de 2023]; 7 (5) 1536-1550.
Disponible de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9042604>
2. Calvo C. Miguel J. Imagen social de las enfermeras y estrategias de comunicación pública para conseguir una imagen positiva. Scielo. [Internet]. 2011; 20(3). [citado el 15 de diciembre del 2023] Disponible de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000200010
3. Franco J. Percepción social de la profesión de enfermería. Enfermería Actual de Costa Rica [tesis doctoral en Internet]. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, [Internet] 2020 [citado el 14 de diciembre de 2023]; (38): 272-281. Disponible de: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/enfermeria/n38/1409-4568-enfermeria-38-272.pdf>
4. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Región de las Américas, 2020. Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. Disponible de: <https://www.paho.org/es/campanas/2020-ano-internacional-profesionales-enfermeria-parteria>
5. Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Ginebra, 2020. La OMS y sus asociados hacen un llamamiento urgente para que se invierta en el personal de enfermería, [citado 7 de abril de 2020]. Disponible de: <https://www.who.int/es/news/item/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in->

nurses#:~:text=Aproximadamente%20el%2090%20por%20ciento,puestos%20est%C3%A1n%20ocupados%20por%20hombres.

6. Cassiani S, Munar E, Umpiérrez A, Peduzzi M, Leija C. La situación de la enfermería en el mundo y la Región de las Américas en tiempos de la pandemia de COVID-19. Panam Salud Public [Internet]. 2020 [citado el 7 de diciembre de 2023]. 44(1): 1-8. Disponible de: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52081/v44e642020.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

7. Zegarra M, Arias Y, Nuñez C, Mannarelli M, Figueroa E, Rodriguez P. Diagnóstico de Enfermería en el Perú, Una perspectiva histórica y de equidad de género. Perú. Coleg Enferm del Perú [Internet]. 2021 [citado en 13 diciembre del 2023]. 362 p. Disponible de: https://www.cep.org.pe/wp-content/uploads/2021/11/Diagnostico_enfermeria.pdf

8. Infobae: Decana del Colegio de Enfermeros exige mejores condiciones de trabajo para personal de salud. [Internet]. Lima: Perú, 2022. [citado 27 agosto del 2022]. Disponible de: <https://www.infobae.com/america/peru/2022/08/27/decana-del-colegio-de-enfermeros-exige-mejores-condiciones-de-trabajo-para-personal-de-salud/>

9. Forbes T, Evans S. From anticipation to confidence: A descriptive qualitative study of new graduate nurse communication with physicians. J Nurs Manag. 2022;30(6):2039-2045. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35506538/>

10. Colegio de Enfermeros del Perú: Reglamento uso del uniforme de la Enfermera y Enfermero Peruanos. [Internet]. Lima: Perú, 2022. [citado 10 de

diciembre del 2022]. Disponible de: <https://www.cep.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/RESOLUCION-No057-22-CDN-CEP-U.pdf>

11. Anco A. Imagen social del profesional enfermero (a) según percepción de usuarios que acuden al centro de salud – San Jerónimo [tesis de licenciatura en Internet] Perú: Universidad Andina del Cusco, 2022 [citado 05 de octubre del 2022]. 95 p. Disponible de: https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/4986/Ana_Tesis_bachiller_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12. Lobato J, Silva Y. Percepción de la imagen social del profesional de enfermería, Chachapoyas, región Amazonas. Rev Científ UNTRM [Internet]. 2020 [citado 19 de diciembre del 2023]; 4 (2): 48-52. Disponible de: <https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CSH/article/view/712>

13. Bustamante A, Martinez Romero J. Percepción social de universitarios externos al área de la salud respecto a enfermería [tesis de licenciatura en Internet]. Mexico: Universidad Autónoma del Estado de Mexico 2021 [citado noviembre del 2022]. 125p. Disponible de: <http://hdl.handle.net/20.500.11799/112761>

14. Herrera P. Imagen social de Enfermería: visibilidad de los cuidados. Con Enf - CODEM [Internet]. 2021 [citado 26 diciembre del 2023]; 16 (2022): 77-93. Disponible de: <https://www.conocimientoenfermero.es/index.php/ce/article/view/207/109>

15. Verena S. La imagen social sobre los Profesionales de Enfermería que tiene una Comunidad de Misiones, Argentina 2021 [tesis de maestría en Internet]. Argentina: Universidad Nacional del Nordeste [citado 15 mayo del 2022]. 136 p. Disponible de: <https://hdl.handle.net/20.500.12219/3063>

16. López A. Apariencia y masculinidad en enfermería: percepción de la vestimenta de enfermeros costarricenses. Enferm univ [Internet]. 2021 [13 de

diciembre del 2023]; 18 (1): 5-15. Disponible de:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632021000100005

17. Marzón A. Reconocimiento social de enfermería: opinión de la profesión en la actualidad [tesis de licenciatura en Internet]. Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo 2020 [citado 27 de noviembre del 2020]. 42p. Disponible de:
<http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7141/1/TESIS%20Ariana%20Janeth%20Maz%c3%b3n%20Morej%c3%b3n%20-ENF.pdf>

18. Cajachagua M, Roque Guerra E, Conque Machaca N, Mamani Contreras R, Chavez Sosa J. Cuidado invisible e Imagen social de la enfermera comunitaria. Ene [internet]. 2022 [citado 21 de diciembre 2023], 16(3): 1297. Disponible de: <https://scielo.isciii.es/pdf/ene/v16n3/1988-348X-ene-16-03-1297.pdf>

19. Phala, A Vega M. Imagen Social Del Enfermero Rural Según La Percepción De Los Usuarios Atendidos En Establecimientos Rurales De Puno, Lima Y Loreto. [tesis de licenciatura en Internet] Perú: Universidad Peruana Unión, Puno, Lima Y Loreto, 2022. [citado 30 de diciembre 2023] 86 p. Disponible de:
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/5509/Angela_Tesis_Licenciatura_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20. Peñafiel J. Percepción Social de la Profesión de Enfermería que tienen los Pobladores Adultos del Centro Poblado “Zona Nueva” Parcona, Ica. [tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad San Luis Gonzaga 2021[citado 31 de del 2023]. 78 p. Disponible de:
<https://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13028/4368/Percepci%C3%B3n%20social%20de%20la%20profesi%C3%B3n%20de%20enfermer%C3%ADa%20que%20tienen%20los%20pobladores%20adultos%20del%20c>

entro%20poblado%20%E2%80%9CZona%20Nueva%E2%80%9D%20Parcon
a%20Ica%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21. Qi J. Monod E. Fang B. Deng S. Theories of Social Media: Philosophical Foundations. Engineering [Internet]. 2018 [citado 22 enero 2024]; 4(1):94–102. Disponible de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809917307993>

22. Alcaide E. Imagen social y contextos socioculturales en el discurso publicitario institucional español con fines sociales. Soprag [Internet]. 2019 [citado 22 enero 2024]; 7(3): 297–334. Disponible de: <https://idus.us.es/handle/11441/95044>

23. Cao H, Song Y, Wu Y, Du Y, He X, Chen Y, Wang Q, Yang H. What is nursing professionalism? a concept analysis. BMC Nurs. [Internet]. 2023 [citado 22 Enero 2024]; 22(1):34. Disponible de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9902819/>

24. Van der Cingel M, Brouwer J. What makes a nurse today? A debate on the nursing professional identity and its need for change. Nurs Philos. [Internet]. 2021 [citado 22 enero 2024]; 22(2):1-10. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33450124/>

25. Lauria E, Barisone M, Busca E, Azzolina D, Airoidi C, Dal Molin A, Casalino M. The social and professional image of the nurse: results of a survey during the Covid-19 pandemic. Prof Inferm. [Internet]. 2022 [citado 22 enero 2024]; 1(75):93-100. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36964919/>

26. Godsey J, Perrott B, Hayes T. Can brand theory help re-position the brand image of nursing? J Nurs Manag. [Internet]. 2020 [citado 22 enero 2024];28(4):968-975. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32166851/>
27. Tello M, Pérez N, Torres B, Nuncio J, Pérez D, Covarrubias I. Percepción del personal de enfermería sobre la cultura y seguridad del paciente. Enferm. glob. [Internet]. 2023 [citado 23 Enero 2024]; ; 22(70): 111-138. Disponible de: <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.531691>
28. Koo M, Lin SC. The image of nursing: A glimpse of the Internet. Jpn J Nurs Sci. 2016;13(4):496-501. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27162121/>
29. González A, Pinto A, Pérez S, Marqués P. Nurse managers' competencies: A scoping review. J Nurs Manag. 2021;29(6):1410-1419. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34018273/>
30. Yokobori H, Iwasaki-Motegi R, Naruse T, Yamamoto-Mitani N. Public Health Nurses' Activities toward Child Abuse Prevention before Childbirth in Japan. Public Health Nurs. 2022;39(6):1346-1354. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35899984/>
31. Pierson C. Retractions in nursing literature: Responsibilities of nurse authors, reviewers, and editors. J Am Assoc Nurse Pract. 2018;30(3):115-116. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29757878/>

32. Molina J, Gallo J. Impact of Nurse-Patient Relationship on Quality of Care and Patient Autonomy in Decision-Making. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(3):835. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32013108/>
33. Sastrawan S, Newton JM, Malik G. Nurses' integrity and coping strategies: An integrative review. *J Clin Nurs*. 2019;28(5):733-744. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30358004/>
34. Strachan P, Kryworuchko J, Nouvet E, Downar J, You J. Canadian hospital nurses' roles in communication and decision-making about goals of care: An interpretive description of critical incidents. *Appl Nurs Res*. 2018;40(1):26-33. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29579495/>
35. Andrade L, Bustamante J, Viris S, Noboa C. Retos y desafíos de enfermería en la actualidad. *Salud y Vida [Internet]*. 2023 Dic [citado 2024 Ene 30]; 7(14): 41-53. Disponible de: <https://doi.org/10.35381/s.v.v7i14.2525>
36. Velásquez S, Cacante J. El concepto de Reconocimiento y su utilidad para el campo de la Enfermería. *Temperamentvm [Internet]*. 2020 [citado 2024 Ene 30]; 16: e12797. Disponible de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-60112020000100019&lng=es
37. García A. Percepción emocional: sociología neurociencia afectiva. *Rev Mex. Soc.*, [Internet]. 2020 [citado 22 enero 2024]; 82(4), 835-863. Disponible de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018825032020000400004&script=sci_abstract

38. Silva F, Ramón C, Vergaray V, Palacios F, Partezani R. Percepción del paciente hospitalizado respecto a la atención de enfermería en un hospital público. *EnfUn* [Internet]. 2015 [citado 7 de abril del 2015]. 12 (2): 80-87. Disponible de: <https://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v12n2/1665-7063-eu-12-02-00080.pdf>
39. Boston K, Stone B. The nursing profession circa 2030. *Nursing*. [Internet]. 2022 [citado 22 enero 2024] ;52(12):34-39. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36394623/>
40. Alcaide E. Imagen social y contextos socioculturales en el discurso publicitario institucional español con fines sociales. *Soprag* [Internet]. 2019 [citado 22 enero 2024]; 7(3): 297–334. Disponible de: <https://doi.org/10.1515/soprag-2019-0026>
41. De Arco C, Suarez C. Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de salud colombiano. *UnySa*. 2018; 20 (2): 171-182. Disponible de: <http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v20n2/0124-7107-reus-20-02-00171.pdf>
42. Peres M, Aperibense P, Dios M, Gómez S, Queirós P. The Florence Nightingale's nursing theoretical model: a transmission of knowledge. *Rev Gaúcha Enferm*. 2021;42(1):1-10. Disponible de: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/FCtdhW9CT3k47gJS9KTSXkk/?format=pdf&lang=es>
43. Lapinski S. La imagen social sobre los Profesionales de Enfermería que tiene una Comunidad de Misiones, Argentina. *Rev. Unidad Sanit*. 2021; 1(3): 29-50. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/>

44. Navarro, G, Boero, P. Jiménez, G. Tapia, L. Hollander, R. Escobar, A. Baeza, M. Espina Á. Valores y actitudes socialmente responsables en universitarios chilenos. *Calidad en la educación*, 2012;36(1), 123-147. Disponible de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652012000100004>
45. Mena D, González V. Imagen social de la enfermería, ¿estamos donde queremos? *Index Enferm [Internet]*. 2018 Jun [citado 2024 Feb 10] ; 27(1-2): 5-7. Disponible de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962018000100001&lng=es.
46. Vera, B. Moreno J. La autonomía de los estudiantes y las designaciones académicas en el campo universitario. *Revista Universidad y Sociedad*, 2020; 12(6), 68-77. Disponible de: <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n6/2218-3620-rus-12-06-68.pdf>
47. González M. La interacción en el camino hacia una comunicología. *ARCIC [Internet]*. 2017 [citado el 13 de febrero del 2024]; 6 (13): 142-172. Disponible de: <http://scielo.sld.cu/pdf/ralc/v6n13/ralc07217.pdf>
48. Fernández P, López P, Márquez M. Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión *Anales de Psicología. ADP [Internet]*. 2008 [citado en diciembre del 2008]; 24 (2): 284-298. Disponible de: <https://www.redalyc.org/pdf/167/16711589012.pdf>
49. Güere P, Teoría del conocimiento virtual [Tesis de Maestría en Internet]. Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú; 2020. 63 p. Disponible de: https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/6845/T010_70454682_M.pdf?sequence=1
50. Villarroig c, Muiños D, La atención: principales rasgos, tipos y estudio [Tesis de Maestría en Internet]. España: Universitat Jaume I; 2018. 26 p. Disponible de:

https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/177765/TFG_2018_VillarroigClaramonte_Laura.pdf?sequence=1&isAllowed=y

51. Hernández R. Mendoza C. Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018. Disponible de: <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>

52. Ramírez M. Imagen social de la enfermera según la percepción de los usuarios de un centro de salud de Lima Metropolitana 2019. [tesis para optar el título de licenciatura] Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2022 [citado 31 de diciembre del 2023]. 78 p. Disponible de: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/18502/Ramirez_am.pdf?sequence=3&isAllowed=y

53. Mastroleo I. Consideraciones sobre las obligaciones postinvestigación en la Declaración de Helsinki 2013. Rev. Bioética y Derecho [Internet]. 2014 [citado 26 de enero 2023]; 2(31): 51-65. Disponible de: <https://dx.doi.org/10.4321/S1886-58872014000200005>

ANEXOS

ANEXO A: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Buen día, somos Fiorella Isabel Cuzcano Villanueva y Pricila Yerlisa Romero Arévalo, bachilleres de la Carrera Profesional de Enfermería, de la Universidad de San Martín de Porres. Nos dirigimos a usted con el agrado de hacerle llegar el presente cuestionario, el cual tiene como objetivo identificar su percepción sobre la labor de la enfermera.

Queremos destacar que esta encuesta es anónima y los resultados serán utilizados con fines de investigación. Agradecemos de antemano su participación.

II. Datos generales:

a) Edad: _____

b) Género:

Femenino ☐

Masculino ☐

III. Instrucciones:

A continuación, se presenta una serie de ítems, seguido de una columna de cinco categorías:- totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo; a lo que deberá ud. Responder con un aspa (x) según considere su respuesta:

Ítems	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1. El uniforme de la enfermera es limpio					
2.La enfermera evidencia buena presentación física					
3. El lugar de trabajo de la enfermera es solo el hospital y centro de salud					
4. La enfermera se preocupa más por el estado físico del paciente					
5. La enfermera es un ejemplo digno de imitar en el cuidado de su salud.					
6.La enfermera le brinda charlas educativas para contribuir al cuidado de su					

salud					
7. Usted observa a la enfermera organizada en su labor					
8. La enfermera demuestra liderazgo en su quehacer					
9. La enfermera actúa en forma independiente en las acciones que realiza					
10. La enfermera actúa solo por indicación del médico					
11. El enfermero(a) se dedica a realizar acciones como inyectar, hacer curaciones y vacunar					
12. La enfermera es responsable en el cumplimiento de sus actividades					
13. Cuando la enfermera lo atiende utiliza un tono de voz suave					
14. La enfermera se dirige a usted con respeto					
15. Al solicitar algo a la enfermera lo atiende y presta ayuda					
16. Cuando el profesional de enfermería lo atiende lo hace con delicadeza y cuidado.					
17. La enfermera responde a sus inquietudes con respecto a su salud					
18. La enfermera, al saludarlo, le muestra cordialidad					
19. Usted considera a la enfermera importante como profesional					
20. La enfermera es reconocida por la sociedad por la labor que realiza.					

ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

El propósito de este protocolo es brindar a los y a las participantes en esta investigación, una explicación clara de la naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella.

La meta de este estudio es realizar el trabajo de investigación imagen social de la enfermera según la percepción de los pacientes que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Surquillo 2024

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una entrevista a profundidad lo que le tomará 45 minutos de su tiempo. La conversación será grabada, así el investigador o investigadora podrá transcribir las ideas que usted haya expresado.

Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.

En principio, las entrevistas serán totalmente confidencial, no se le pedirá identificación alguna.

Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo de la investigación, usted es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder.

Muchas gracias por su participación.

Yo,doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con

.....

Dentro de los beneficios está la contribución al desarrollo de la investigación, la cual servirá de aporte científico a la mejora continua con resultados que podrán extenderse a ámbitos nacionales.

Nombre completo del participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador

Firma

Fecha